Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Traumatisme crânien

Choc à la tête observé ou suspecté, adulte et enfant : alerter selon les critères, surveiller 24 h, y compris la nuit.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou se réveille mal, convulsion, ne bouge plus un bras ou une jambe, parole anormale, douleur du cou.

1 · Je sécurise

- Douleur du cou : **ne pas bouger la tête**, ne pas asseoir.
- Ne pas laisser seule la personne jusqu'à l'avis de l'IDE.
- Plaie du cuir chevelu : comprimer avec une compresse propre.
- Bosse : froid 10 min dans un linge.

2 · J'observe et je mesure

- Heure du choc ? Perte de connaissance ?
- Éveil, parole habituels ? Mal de tête, vomit ?
- Pouls, TA, SpO2 ; glycémie capillaire si diabète (AS/AP).
- Bleu autour des yeux, liquide clair par le nez ou l'oreille ?
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** (voir le plan de soins).

3 · J'agis

- Prévenir l'IDE **dans tous les cas**.
- Remplir la **grille horodatée** : éveil, parole, 4 membres, vomissements, paramètres.
- **La nuit : réveiller** aux heures de la grille (au moins 2 fois) : réveil habituel ?
- Non communicant, enfant : comparer à l'habituel.
- Plaie → protocole « Plaie simple ».

Je ne fais pas

- Laisser dormir toute la nuit sans réveil prévu.
- Faire boire ou manger une personne somnolente ou qui vomit.
- Donner un antalgique « si besoin » sans validation de l'IDE.
- Attendre le matin si un signe d'alerte apparaît.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- **Anticoagulant** ou **deux antiagrégants**, même si tout paraît normal.
- Somnolence, confusion nouvelle, **plus d'un vomissement**, convulsion.
- Ne se souvient pas des 30 min avant le choc ; liquide clair par le nez ou l'oreille.
- Enfant mou, inconsolable ou somnolent ; signe de gravité sans IDE joignable.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **65 ans ou plus sous un antiagrégant** : avis médical sans délai (scanner dans les 8 h).
- Tout choc à la tête, même sans signe : l'IDE décide de la conduite.
- Mal de tête croissant, un vomissement, grosse bosse, plaie.
- Pouls < 50 ou > 120/min, PAS < 100 ou > 200 mmHg, SpO2 < 90 %.

Je surveille et je trace

- **24 h** de surveillance selon la grille du protocole IDE « Surveillance traumatisme crânien ».
- Tracer : heure, mécanisme, chaque passage de la grille, qui a été prévenu.
- Jours suivants : mal de tête croissant, confusion, chutes → IDE.

Mention de sécurité

Un traumatisme crânien peut s'aggraver dans les heures qui suivent. Anticoagulant ou deux antiagrégants = 15 ; la nuit, on réveille selon la grille.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; NICE NG232 (2023) ; Urg'ARA/ARS ARA, EHPUR, fiche Traumatisme crânien (MAJ 2025) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-TC | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature